Tribunal de Justiça da Paraíba
Vara Única de Picuí

PROCESSO Nº 0001277-64.2016.8.15.0271

Natureza: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, JOANA D ARC DE ARAUJO COSTA DANTAS

REU: ESTADO DA PARAIBA

SENTENÇA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO A SAÚDE – SOLIDARIEDADE DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO LEGAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos etc.,

Trata-se de ação civil púbica envolvendo as partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a parte autora que um usuário do sistema público de saúde necessita submeter-se a procedimento cirúrgico para tratamento e diagnóstico de doença.

Aduz que a parte promovida não vem disponibilizando os meios necessários ao correto tratamento do usuário, havendo riscos à saúde e vida do mesmo.

Sustenta que o fornecimento/realização do procedimento cirúrgico pelo promovido é obrigação do poder público.

Pede ao final a concessão de antecipação de tutela e a procedência do pedido a fim de obrigar o promovido a fornecer gratuitamente o procedimento cirúrgico ao paciente indicado na inicial, conforme tratamento prescrito pelo médico.

Foi deferida a antecipação de tutela (id. 20628276 - Pág. 92/93), à qual foi atribuído resultado prático equivalente por meio de sequestro de valores (id. 20628304 - Pág. 17).

Devidamente citado, o Estado deixou de contestar o pedido no prazo legal.

Autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, **decreto a revelia do réu**, tendo em vista que, conquanto devidamente citado, deixou transcorrer o prazo contestacional *in albis*, sem, contudo, atribuir-lhe o efeito legal previsto no art. 344 do CPC.

Outrossim, analisando os autos, tenho que o feito comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, nos termos do que dispõe o art. 355, I, do CPC.

Ademais, antes de enfrentar o mérito, faz-se necessário tecer algumas considerações preliminares acerca da legitimidade ativa do Ministério Púbico em tais casos, bem como a legitimidade passiva dos entes federados em relação a demandas de saúde, como a presente.

Legitimidade ativa do Ministério Público para demandas individuais.

A nossa Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais se pode elencar a defesa do direito fundamental à saúde.

É possível, portanto, a intervenção do Ministério Público se este pretende reparar uma lesão constitucional a um direito individual indisponível que afeta uma coletividade indeterminada de pessoas e efetivar ações estatais mínimas no tocante aos serviços de saúde pública.

Sua atuação não é admitida na defesa de direitos individuais, tendo em vista que tal atribuição cabe, por expressa previsão constitucional (artigo 134), à Defensoria Pública.

No entanto, como exceção a essa regra, reconhece-se a legitimidade do Ministério Público para a defesa de idosos ou de crianças ou adolescentes, por força do art. 74, inciso I, do Estatuto do Idoso e artigo 201, inciso V, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

E, no caso dos autos, além de inquestionáveis os motivos que levaram o órgão ministerial a promover a presente ação-proteção de direito indisponível – fato é que o Ministério Público aqui defende interesse individual e exclusivo do(a)(s) paciente(s) qualificado(a)(s) na exordial, sendo patente a legitimidade ativa, bem como a adequação da ação civil pública.

Legitimidade passiva e chamamento dos outros entes estatais para o processo.

Nossa Carta Magna, no art. 196, afirma, in verbis: "**Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação".**

Da escrita do artigo 196 da nossa Constituição, poder-se-ia concluir que a referida norma programa, indicando projeto que seria alcançado pelo Estado. Ocorre que o Estado, efetivamente, deve proporcionar a prevenção de doenças, assim como oferecer os meios necessários para que os cidadãos possam restabelecer sua saúde.

O STF pôs fim no ato das fazendas públicas que procuravam se esquivar de fornecer medicamentos necessários à sobrevivência de pessoas enferma.

Sobre o tema diz a jurisprudência:

> STF: O preceito do artigo 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que 'à saúde, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção e recuperação''. A referência contida no preceito, a

'Estado' mostra-se abrangente, a alcançar a União Federal, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios (STF – AI 2238.328/RS. Min. Marco Aurélio – DJ 11.05.1999).

STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte Especial firmou a orientação no sentido de que não é necessário o sobrestamento do recurso especial em razão da existência de repercussão geral sobre o tema perante o Supremo Tribunal Federal. (Resp.1.143.677/RS, Min. Luiz Fux, Dje de 4.2.2010). 2. O entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. 3. Agravo regimental não provido. (STJ: AgRg no Resp. 1159382/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, Dje 01/09/2010).

Diante do exposto, tem-se a conclusão de que, ainda que determinado medicamento ou serviço seja prestado por uma das entidades federativas ou instituições a elas vinculadas, nada impede que as outras sejam demandadas, de modo que todas elas (União, Estado e Municípios) têm, igualmente, legitimidade para figurar no polo passivo em causas que versem sobre o fornecimento de medicamentos, bem como atendimento médico a pacientes do SUS.

Mérito.

Ao compaginar os autos, pela documentação juntada, entendo que o pedido do autor merece acolhimento, haja vista que restou comprovado que a pessoa indicada nos autos apresenta problema de saúde, com diagnóstico preciso, razão pela qual necessita submeter-se a procedimento médico-cirúrgico, cuja disponibilidade não lhe foi concedida pelo sistema único de saúde mantido pela promovida.

De igual modo, verifico pelas observações médicas, que o procedimento cirúrgico prescrito é imprescindível para o tratamento da saúde do paciente.

Desta forma, tenho que o pedido merece acolhimento, uma vez que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade e há comprovação da necessidade da cirurgia requerida, conforme documentos que instruem a inicial.

Ressalte-se que o art. 2º da Lei nº 8.080/90 estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e obrigação do poder público que deve promover todas as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Com efeito, observo que a não realização do procedimento cirúrgico trará danos irreparáveis ao paciente, eis que não será possível o tratamento adequado para o paciente, afrontando o princípio de dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, importante destacar que a saúde é tratada na Constituição Federal com status de relevância pública (art. 197), cabendo ao poder público através de políticas sociais e econômicas reduzir o risco e promover o acesso universal e igualitário de todos à saúde.

Importa ainda observar que o paciente é pessoa desprovida de recursos financeiros suficientes para custear a realização da cirurgia médica, fato que justifica ainda mais o deferimento do pedido.

Por fim, cumpre lembrar que a União, os Estados e os Municípios são solidários na responsabilidade de prestar o serviço de saúde, sendo, portanto, legítimo o pedido formulado contra o promovido contra o Estado da Paraíba.

A jurisprudência do STJ confirma a responsabilidade solidária da União, Estados-Membros e Municípios e que qualquer desses entes tem *legitimidade ad causam* para figura no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

Citamos o julgado do STJ no **AgRg no Ag nº 1107605/SC**, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 03/08/10.

De igual modo é a jurisprudência dos Tribunais Federais, conforme decisão do TRF-1ª Região, na AC: 15401 BA 2007.33.00.015401-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.149 de 14/01/2013, com fundamento em jurisprudência do STF.

Senão vejamos a ementa desse último julgado citado:

> CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E

198). LEI N. 8.080/90. EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA PARA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. 1. Há responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum deles, nem em formação de litisconsórcio necessário. Precedentes do STF. 2. Se o fornecimento do medicamento à autora somente ocorreu após a concessão da medida liminar, não há como afirmar a desnecessidade da tutela jurisdicional. Interesse processual reconhecido. 3. Perícia judicial concluiu que: No caso em apreço não se trata de substituir fármacos para tratamento de Mal de Alzheimer, mas de considerar que a Examinada é portadora de dependência química farmacológica de longa data, em condições de alheamento psicológico total que a impede de causar sintomas ou sofrimentos e diante de antecedentes adversos de tentativas malogradas de redução posológica, abrindo iguais expectativas para substituições farmacológicas com os riscos obscuros envolvidos. 4. O direito à saúde está garantido na Constituição Federal (arts. 196 e 198) e a Lei n. 8.080, de 19/09/1990, é explícita ao estabelecer o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). 5. Ao Poder Público incumbe o dever de garantir a observância desse direito público subjetivo, por meio de políticas públicas que visem à proteção e recuperação da saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos/tratamentos

aos necessitados, sejam eles de alto custo ou não. 6. Informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que: "(...) O protocolo de dispensação para esta doença definido pelo MS não contempla o estágio avançado (...) e não há qualquer outro medicamento aprovado que substitua a Memantina. A Vonlefaxina, cujo nome comercial referido na ação judicial é o Efexor, medicamento antidepressivo, inibidor de receptação da resotonina e noradrenalina, é largamente utilizado e com eficácia comprovada para depressão maior". 7. Não há motivo para impor à Administração necessariamente o fornecimento de medicamento de marca, devendo a tutela jurisdicional possibilitar o fornecimento de remédio genérico (art. 3º da Lei n. 9.787/99 c/c art. 3º, XVIII, da Lei n. 6.360/76), sob pena de injustificada oneração do SUS. 8. Há necessidade de condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 (seis) meses, a fim de prevenir o fornecimento indevido de tratamento. 9. Apelações do Estado da Bahia e da União não providas. 10. Remessa oficial parcialmente provida para condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação de prescrição médica atualizada, no máximo, a cada seis meses e para assegurar a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, caso exista ou venha a existir.

Portanto, concluo que o paciente indicado nos autos tem direito ao medicamento prescrito, conforme orientação médica.

Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE o pedido** para confirmar os efeitos da antecipação de tutela e condenar o Estado da Paraíba a **fornecer, realizar ou custear o procedimento cirúrgico indicado (NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA)**, conforme documento médico de id. 20628276 -

Pág. 44, **de forma gratuita, em favor da Sra. JOANA D ARC DE ARAUJO COSTA DANTAS**, qualificada nos autos.

Sem custas, por não ser cabível na espécie (art. 18 da Lei nº 7.347) e sem condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ no julgamento do AgRg no Resp nº 1386342/PR, Relator Min. Mário Campbell, julgado em 27/03/14 e publicado em 02/04/14.

Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 15 dias, comprovar a correta utilização dos valores liberados pelo alvará judicial de id. 20628304 - Pág. 23.

Caso seja interposto recurso, intime-se a parte recorrida a apresentar contrarrazões no prazo legal e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, **independentemente de novo despacho**.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Picuí, data e assinatura eletrônicas.

Anyfrancis Araújo da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA
27/04/2020 18:37:01
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 30173681

20042718370069900000

IMPRIMIR GERAR PDF